



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Série de Protocolos Institucionais de Urgência — Pronto-Socorro Natal Diegues (Estiva Gerbi/SP)

Índice geral dos 36 protocolos (35 documentos), estrutura comum, rede de referência pactuada, pendências estruturais consolidadas para a gestão e plano de implantação/auditoria

Código	PS-ND-00	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

1. Como ler a série

Todos os protocolos seguem a mesma estrutura de 10 seções: 0 Escopo e fontes • 1 Queixa • 2 Clínica/gravidade • 3 Exame físico • 4 Propedêutica • 5 Fisiopatologia • 6 Fluxo (fluxograma) + metas de tempo + critérios de alta • 7 Tratamento (doses/vias) • 8 Condução (transferência, relatório, estrutura, indicadores) • 9 Divergências entre fontes e itens [VERIFICAR] • 10 Referências. Cada documento é uma **minuta (versão 1.0)** com campos de aprovação (Diretor Clínico e Coordenação do PS), vigência e revisão em branco; as doses trazem a fonte; os itens marcados **[VERIFICAR]** exigem conferência local antes da aprovação; os **eventos sentinela** e indicadores de cada protocolo compõem a auditoria mensal proposta.

Cenário fixo: PS municipal sem UTI, sem hemodinâmica, sem TC/RM, sem endoscopia, sem cirurgião de plantão. Função: estabilizar, tratar o que é tratável localmente com segurança, não errar por excesso nem por omissão (prevenção quaternária), e regular no tempo certo. **Rede pactuada (04/09/2026):** Hospital Municipal Tabajara Ramos (Mogi Guaçu) — casos clínicos, UTI, hemodinâmica; Santa Casa de Mogi Guaçu — cirúrgicos, ginecológicos/obstétricos e pediatria; regulação CROSS-SP / SAMU 192.

2. Índice dos protocolos

Nº	Protocolo	Arquivo	Págs	Fontes-âncora principais
01	SCA / IAM	PS_NatalDiegues_01_SCA_IAM.pdf	9	SBC 2015/2021/2025; ACC/AHA 2025; ESC 2023; STREAM
02	Cetoacidose diabética e EHH (02+17)	PS_NatalDiegues_02_Cetoacidose_EHH.pdf	11	SBD 2026; Consenso ADA/EASD 2024; ISPAD 2022
03	AVC isquêmico, HIC, HSA, AIT	PS_NatalDiegues_03_AVC_Isquemico_Hemorragico.pdf	10	PCDT-MS 2023; AHA/ASA 2026; AHA-HIC 2022
04	Agitação psicomotora e crise psiquiátrica	PS_NatalDiegues_04_Agitacao_Crise_Psiquiatrica.pdf	13	ABP 2019; BETA 2012; TREC; Lei 10.216
05	Sepse e choque séptico	PS_NatalDiegues_05_Sepse_Choque_Septico.pdf	10	SSC 2026; ILAS; Sepsis-3
06	Víroses: GEA, IVAS, síndrome gripal/SRAG, bronquiolite	PS_NatalDiegues_06_Viroses.pdf	11	MS/OMS planos A-B-C; IDSA; AAP; MS influenza
07	Asma aguda	PS_NatalDiegues_07_Aasma_Aguda.pdf	10	GINA 2026; SBPT 2020; PCDT-MS 2021
08	Infecção do trato urinário	PS_NatalDiegues_08_ITU.pdf	10	IDSA 2025; EAU 2025; IDSA-BA 2019; AAP
09	IC descompensada	PS_NatalDiegues_09_IC_Descompensada.pdf	9	DBIC 2018/2021; ESC 2021/2023; DOSE/ADVOR/STRONG-HF
10	Pneumonia adquirida na comunidade	PS_NatalDiegues_10_Pneumonia_PAC.pdf	10	SBPT 2018; ATS/IDSA 2019; ERS 2023; CAPE COD
11	Dengue e arboviroses	PS_NatalDiegues_11_Dengue_Arboviroses.pdf	12	MS Dengue 6ª ed. 2024; MS Chikungunya 2024; OMS 2025
12	Anafilaxia	PS_NatalDiegues_12_Anafilaxia.pdf	8	SBP/ASBAI 2021; WAO 2020; PP 2023
13	Hipoglicemia	PS_NatalDiegues_13_Hipoglicemia.pdf	8	SBD R21-R23; ADA 2026; ISPAD 2022; Endocrine Society
14	Crise convulsiva e EME	PS_NatalDiegues_14_Crise_Convulsiva_EME.pdf	11	ILAE 2015; AES 2016; ESETT; NCS 2012
15	Crise hipertensiva	PS_NatalDiegues_15_Crise_Hipertensiva.pdf	11	DBHA 2025 cap. 11; AHA 2024; ESC 2024
16	DPOC exacerbado	PS_NatalDiegues_16_DPOC_Exacerbado.pdf	10	GOLD 2026 (Roma); ERS/ATS 2017; PCDT-MS 2021
18	Arritmias com pulso	PS_NatalDiegues_18_Arritmias.pdf	10	AHA 2025; ESC-FA 2024; ESC-TSV 2019; ESC-AV 2022
19	TEP / TVP	PS_NatalDiegues_19_TEP_TVP.pdf	12	ESC 2019; CHEST 2021; ASH 2020; PEITHO/YEARS
20	Dor abdominal aguda	PS_NatalDiegues_20_Dor_Abdominal_Aguda.pdf	11	WSES 2020/2022; TG18; ACG-pancreatite 2024
21	Cólica renal	PS_NatalDiegues_21_Colica_Renal.pdf	8	EAU 2025; PATHAN 2016; SUSPEND/STONE
22	Hemorragia digestiva alta	PS_NatalDiegues_22_HDA.pdf	9	ACG/ESGE 2021; Baveno VII; AASLD 2024
23	Intoxicações exógenas	PS_NatalDiegues_23_Intoxicacoes.pdf	14	AACT/EAPCCT; DART 2023; Eddleston 2008; AHA-TOX 2023

Nº	Protocolo	Arquivo	Págs	Fontes-âncora principais
24	Hipercalcemia e distúrbios eletrolíticos	PS_NatalDiegues_24_Hipercalcemia_Eletrolitos.pdf	10	UKKA 2023; EU-hiponatremia 2014; Sfe 2016
25	Síncope	PS_NatalDiegues_25_Sincope.pdf	10	ESC 2018; ACC 2017; CSRS
26	Celulite/erisipela e IPPM	PS_NatalDiegues_26_Celulite_Erisipela_IPPM.pdf	11	IDSA 2014; WSES 2018/2022; IWGDF 2023
27	Acidentes por animais	PS_NatalDiegues_27_Acidentes_Animaiss.pdf	10	MS-GVS 2024; MS 2001; NT 8/2022 (raiva); Butantan
28	Queimaduras	PS_NatalDiegues_28_Queimaduras.pdf	11	ABA 2023; MS 2012; ISBI; ATLS
29	TCE	PS_NatalDiegues_29_TCE.pdf	11	NICE 2023; CCHR; PECARN; BTF 2016; CRASH-3
30	PCR — BLS/ACLS institucional	PS_NatalDiegues_30_PCR_ACLS.pdf	10	AHA 2025; SBC-RCP 2019; ERC 2021
31	Abstinência alcoólica	PS_NatalDiegues_31_Abstinencia_Alcoolica.pdf	9	ASAM 2020; NICE; CIWA-Ar; EFNS 2010
32	Cefaleia na emergência	PS_NatalDiegues_32_Cefaleia.pdf	10	SNOOP10; Ottawa; AHS 2016; ESCMID 2016
33	Lombalgia aguda	PS_NatalDiegues_33_Lombalgia.pdf	10	NICE NG59; ACP 2017; Lancet 2018
34	Trauma — ATLS resumido	PS_NatalDiegues_34_Trauma_ATLS.pdf	11	ATLS 10; EU-BLEED 2023; CRASH-2; PROPPR
35	Violência — atendimento, notificação e rede	PS_NatalDiegues_35_Violencia.pdf	11	MS-VS 2012; MS-PEP 2021/24; Leis 11.340/13.931/12.845/ECA
36	Abordagem da dor no PS	PS_NatalDiegues_36_Dor.pdf	12	AAEM 2018; ACEP 2020; SBED; ACEP-PSA

3. Pendências estruturais consolidadas — para a gestão do PS e da Secretaria de Saúde

Itens recorrentes nos protocolos que dependem de decisão administrativa, aquisição ou pactuação. Sem eles, os protocolos correspondentes operam em modo "estabilizar e transferir". Ordem de prioridade sugerida pelo impacto em mortalidade evitável.

Prioridade	Pendência	Protocolos	Responsável sugerido
1	Sangue O negativo / agência transfusional com acesso em ≤30 min; tipagem; CCP e vitamina K para reversão de anticoagulantes	22, 34, 29, 03, 19	Secretaria/Hemo centro regional
1	Desfibrilador bifásico com marca-passo transcutâneo e pás adesivas; capnografia; videolaringoscópio; acesso intraósseo; carrinho de emergência por setor com checklist	30, 18, 34, 28	Coordenação PS/compras
1	Laboratório em ≤30-60 min: gasometria com lactato/eletrolitos (K, Na, Ca iônico), troponina ultrasensível (cortes do ensaio), D-dímero (unidade), lipase, PCR, cetonemia capilar, dosagem de paracetamol	01, 02, 05, 16, 19, 20, 23, 24	Laboratório/Secretaria

Prioridade	Pendência	Protocolos	Responsável sugerido
1	Antídotos e fármacos críticos em estoque 24 h: atropina (≥50 amp), pralidoxima, N-acetilcisteína IV, naloxona, flumazenil, glucagon, gluconato de cálcio, bicarbonato, MgSO ₄ , tiamina (≥30 amp), piridoxina, emulsão lipídica, hidroxocobalamina (fluxo), adrenalina (≥5), alteplase/tenecteplase (≤10 min), terlipressina/octreotida, HNF/enoxaparina, ácido tranexâmico, nitroglicerina, esmolol, amiodarona, adenosina, diltiazem IV, levetiracetam IV, cetamina, kit PEP + levonorgestrel + penicilina benzatina + vacina/IgHB, soros antiveneno (se ponto de soro), SAR/IgHAR (fluxo)	01, 03, 12, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 35	Farmácia/CCIH/Secretaria
1	Ponto de soroterapia (antiveneno) e vacina/IgHAR antirrábica — definir se o PS estoca e onde está a referência	27	Vigilância Epidemiológica
2	Pactuações de fluxo com horários: endoscopia 24 h (HDA), TC 24 h + neurocirurgia (TCE/AVC), RM/cirurgia de coluna (cauda equina), CTQ (queimados), centro de trauma, hemodinâmica/tele-AVC, CPRE, diálise de urgência, câmara hiperbárica; tempo de transporte estimado até Mogi Guaçu	03, 22, 29, 33, 28, 34, 20, 24, 23	Secretaria/CROSS/DRS XIV
2	VNI/BiPAP com máscaras, máscaras de Venturi, alto fluxo nasal, POCUS com treinamento (FAST, VD, TVP, hidronefrose, aorta, abscesso, VCI)	07, 09, 16, 19, 20, 21, 26, 34	Coordenação PS/educação permanente
2	Antibiograma acumulado local (CCIH/LACEN) e validação dos esquemas empíricos pela CCIH; prevalência de MRSA comunitário	05, 08, 10, 20, 26	CCIH
2	Leito de observação monitorada 6-24 h (síncope, DPOC, IC, abstinência, intoxicação) com enfermagem treinada (CIWA-Ar, escalas de dor, RASS)	25, 16, 09, 31, 23, 04, 36	Coordenação PS
2	Rede de proteção com telefones afixados: Conselho Tutelar, DDM, CREAS, IML, serviço de referência em violência sexual, CAPS/CAPS AD/CAPSij, Vigilância; fluxo de notificação SINAN e de comunicação obrigatória (Lei 13.931, ECA, Estatuto do Idoso); comunicação ao MP em internação involuntária	35, 04, 23, 31	Secretaria/Assistência Social/Vigilância
3	Protocolos de enfermagem: analgesia na triagem, CIWA-Ar horária, glicemia/SpO ₂ /temperatura em todo agitado, checklist de contenção, código azul (papéis), cronômetro do EME	36, 31, 04, 30, 14	Diretor Clínico/COREN/Coordenação de enfermagem
3	Insumos de baixo custo e alto impacto: espaçadores para dispensar, peak flow com bocais, oftalmoscópio, agulha atraumática de PL, fita de Broselow, cinta pélvica, torniquetes, colares, manta térmica, aquecedor de soro, atomizador nasal, faixas de contenção, régua de Glasgow, cartazes (SNOOP10, doses pediátricas, energias de cardioversão)	07, 32, 34, 28, 04, 29, 30	Compras
3	Treinamento: BLS anual (todos), ACLS/PALS bienal, ATLS/PHTLS, simulação trimestral in situ (código azul, cesariana perimortem, hipercalcemia, criança, via aérea difícil), de-escalação verbal, acolhimento à violência, bloqueios regionais, sedação para procedimentos	30, 34, 04, 35, 36	Educação permanente
3	Contrarreferência formal para a APS/UBS em ≤7 dias (IC, DPOC, asma, HAS, síncope, dor crônica, abstinência) com busca ativa pelo ACS; dispensação garantida na alta (DOAC/PCDT, dapagliflozina, corticoide inalatório, kit PEP, anticoagulante)	09, 16, 07, 15, 19, 35, 36	APS/Secretaria
3	Aprovação institucional: revisão médica de cada minuta, ajuste ao dose lock pediátrico, assinatura do Diretor Clínico e Coordenação, vigência e ciclo de revisão (12 meses ou quando diretriz mudar); registro Utstein e comitê de óbitos	Todos	Diretor Clínico

4. Auditoria e revisão

- Cada protocolo traz 6–9 indicadores e eventos sentinela; sugere-se um painel mensal com os 12 indicadores transversais: tempo porta-ECG, porta-antibiótico na sepse, porta-adrenalina na anafilaxia, porta-benzodiazepínico no EME, glicemia registrada em todo rebaixamento, escala de dor na triagem, notificações SINAN em 24 h, contato com CAPS antes da alta, transfusão com Hb pré <7, opioide em migrânea/lombalgia, TC/RX sem indicação, e mortalidade evitável revisada.
- Revisão da série: anual ou quando uma diretriz-âncora mudar (as datas das fontes estão na seção 0 de cada protocolo). Itens já sinalizados: SSC pediátrico 2026, DBHA 2025 texto integral, GINA 2026 Box 9-6, SBC-FA atualização, SBN/SBCe/SBED edições vigentes.
- Os scripts geradores (Python/ReportLab) e a biblioteca comum (ps_base.py) permitem regerar qualquer protocolo com alterações locais em minutos; recomenda-se guardar a versão-fonte junto com o PDF aprovado.

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração